



2

58. ÅRGANG | 02 • 2021

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLÆGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Hvordan skabes et styrket
PPR? – aktuelle bevægelser
og dilemmaer

PPT nr. 2-2021

**Planer för samverkan kring barn
och unga i Skottland och Sverige
– ett jämförande perspektiv**

Af Mats Anderberg och Torbjörn Forkby

Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv



"I Danmark har flere kommuner heriblandt København samarbejdet med andre kommuner i Norden forbindelse med Nordisk Ministerråds projekt om tværfaglighed og også om børns ret til at blive lyttet til og inddraget omkring beslutninger i deres liv. Mats Anderberg fra Linnéuniversitetet i Sverige har undersøgt forskellene på de mere gængse handleplaner som SIP i Sverige med "Barnets Plan" fra GIRFEC projektet i Skotland, som Barnets Stemme projektet i Indre By-Østerbros PPR funktion og i region Kronoborg i Sverige begge er inspireret af i deres handleplaner. Undersøgelsen viser et opgør med silotænkning, de professionelles og lederens ansvar og roller, involvering af forældre og barn som aktører på handleplansmøderne, fokus på at det er barnet plan og ikke fagpersonernes, opfølgning af planerne, tidsperspektivet, strukturen, fremhævelse af skolens rolle m.v."

*Av Mats Anderberg och Torbjörn Forkby.
Anderberg är docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet och Forkby är professor i socialt arbete vid samma institution.*

Författarna förenas av att under många år ha bedrivit praktisknära forskning kring barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Förebyggande av elevers skolsvårigheter, navigeringsmönster bland unga i utsatta livssituationer samt implementering av nya arbetssätt och metoder är några av deras intresseområden.

Arbetet med barn och unga i komplicerade och utsatta livssituationer involverar i många fall ett flertal professionella, organisationer och huvudmän. En återkommande kritik är att samverkan för att få till stånd fungerande stöd inte fungerar, tillsammans med motsvarande återkommande policyintentioner om att utveckla bättre samverkan. För att lyckas med det behövs en ömsesidig och gemensam målsättning för arbetet, att olika organisati-

onsnivåer inbegrips men även att konkreta verktyg och arbetssätt som möjliggör god samverkan tas fram (se Grefve, 2017).

Reformering av lagstiftningen kring samverkan har genomförts i Sverige och regeringsuppdrag till centrala myndigheter om att utveckla tidiga och samordnade insatser samt s.k. samordnade individuella planer (SIP) kan ses som olika uttryck för policyn. Det sedan några år tillbaka mest omfattande

policybidraget kan ses i ambitionerna om införandet av modellen Getting it right for every child (GIRFEC) på svensk mark. Ett sådant försök återfinns i Kronobergs län vilket studeras med en omfattande följeforskning, från vilken denna artikel stammar. Det centrala verktyget för planering och samverkan kring utsatta barn inom GIRFEC-modellen utgörs av "Barnets plan". Detta verktyg uppvisar stora likheter med SIP i såväl utformningen av instrumentet som i hur det praktiskt ska komma till användning. Båda utgår också från Barnkonventionen, avser skapa helhetlig förståelse kring barns behov samt har intentionen att tydliggöra ansvarsförhållanden och samordna erbjudna insatser. Samtidigt uppvisar planerna skillnader beträffande barns och ungas deltagande, som skulle kunna ha betydelse för hur arbetet med barn och unga bedrivs och även för implementeringen av GIRFEC.

Inledning – policyn i Sverige och Skottland

En mindre andel barn och unga befinner sig i så komplexa livssituationer att dessa kräver ett koordinerat och tvärprofessionellt stöd från flera verksamheter. Ett flertal statliga utredningar och rapporter har samtidigt konstaterat att samarbetet brister på grund av en utbredd silo-mentalitet, bristande tillit och samsyn, otydliga och otillräckliga mandat för att axla ansvaret samt att sekretessfrågor begränsar arbetet. Sammantaget ger det upphov till att ett fragmenterat stöd når aktuella barn och föräldrar (Grefve, 2017; SKL, 2019; Socialstyrelsen,

2007; SOU, 2016). Barn och unga riskerar därför att "falla mellan stolarna" mellan organisationernas ansvarsområden:

Det förefaller som att de barn som har mest behov av kontinuitet är också de som får träffa flest personer. Omfattande processer löper i parallella spår med flera inblandade aktörer, där skolan, socialtjänsten och vården arbetar med hänvisning till olika lagrum. Samverkan förefaller handla mer om att avgöra ansvar än att hjälpa dem man är till för (Hansson, 2018, s. 9).

Ett flertal förklaringar till problematiken har presenterats: en ökad specialisering och organisering i stuprör, olika verksamhetskulturer, skilda regelsystem, olika budgetar och begränsade resurser (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Blomqvist, 2012; Huxham, 2003; Widmark, 2015).

År 2010 kompletterades befintliga lagar med tillägg om införandet av en samordnad individuell plan (SIP), vars syfte var att öka kraven på att berörda verksamheter ska samverka och det på ett mer holistiskt sätt. Intentionen var att barn och unga skulle få sina behov tillgodosedda och "inte 'tappas bort' eller 'bollas' mellan de ansvariga" och verksamheterna gavs en gemensam skyldighet att inte vältra över ansvaret på varandra (Socialutskottet, 2017, s. 6). Skolverket & Socialstyrelsen (2018) har i samma anda fått ett regeringsuppdrag att verka för och utveckla en förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen så

att barn och unga i behov av stöd får *tidiga och samordnade insatser*. Dessa myndigheter har också skapat regionala nätverk och arrangerat utbildningar för kommuner och regioner, vilket kan ses som ”mjuk policystyrning” vilken avser påverka sättet att tänka och agera som kompletterar den tidigare nämnda ”hårda” lagstiftningen (Kalkan et al, 2015). Sverige har också inspirerats av internationella policyströmmar (Kingdon, 2011) av hur sättet att avhjälpa brister med samverkan runt barn och unga har lösts, exempelvis det omfattande reformarbete som skett i Skottland (SKL, 2018; Grefve, 2017). Dessa initiativ har även kopplats samman med, och sannolikt också fått ökad kraft och aktualitet genom att Barnkonventionen antogs som svensk lag 2020.

Idag pågår åtminstone fyra svenska utvecklingsförsök med syfte att utveckla tidigare och samordnade insatser för barn och unga som hämtat inspiration från GIRFEC, varav Kronobergs län är ett (Anderberg et al, 2020). Motsvarande intresse finns även i Danmark (Colville et al, 2017).

GIRFEC utgör sedan 2009 i Skottland ett samlat nationellt policyramverk i syfte att förbättra alla skotska barns och ungdomars välbefinnande och att göra deras röster centrala i eventuella bedömnings-, planerings- och stödprocesser. Konceptet bygger på en helhetsyn på barn och unga, nära samverkan mellan olika verksamheter, förebyggande arbete med tidiga insatser för att stödja barn och ungdomar i riskfyllda livssituationer samt deras familjer (Colles et al, 2016). För att underlätta iden-

tifiering av problematiska situationer som kan hindra barns hälsa och utveckling används det s.k. *välbefinnandehjulet* som ett holistiskt bedömningsverktyg innehållande åtta indikatorer för att uppnå fyra övergripande mål: att barn utvecklar bra självförtroende, blir framgångsrika i sitt lärande, är aktiva deltagare i sina liv och ansvarsfulla medborgare. Andra centrala delar i modellen utgörs av två specifika professionella roller: den särskilda namngivna personen som naturligt finns i barns och ungas vardag och *den ansvariga samordnaren* när fler än två verksamheter är involverade.

Ytterligare en viktig del i GIRFEC-ramverket utgörs av den s.k. *barnets plan* (BP), som används vid planering och genomförande av insatser. En anledning till framtagandet av detta gemensamma planeringsinstrument var att barn med en omfattande psykosocial problematik ofta hade ett flertal parallella vård- eller handlingsplaner till följd av flera olika myndighetskontakter (Aldgate, 2008):

”The goal was to incorporate pre-existing elements with new ideas. .../... Each discipline – health, education, and social work – had its own way of thinking and writing, and the first versions of a multi-agency plan were simply condensed versions of the previous process: this is what education thinks, this is what social work thinks, this is what health thinks.”
(Peterson, 2016, s. 117).

De professionella från olika verksamheter som träffar familjen skapar således

en gemensam handlingsplan. Barnets plan kan t.ex. initieras av skolan när en elev behöver ytterligare stöd och från minst en annan myndighet för att främja deras hälsa, lärande och utveckling. Planen innehåller då både de pedagogiska mål som ska uppnås för eleven och det ytterligare stöd som krävs för att en samordning av dessa ska kunna ske (Scottish Government, 2017).

Syftet med denna studie är att redogöra för det aktuella kunskapsläget kring samordnade planer för barn och unga i Skottland och i Sverige, samt att jämföra utformning och tillämpning av dessa och vilken betydelse respektive planer uppfattas ha fått för barn, föräldrar och professionella.

Metod

En narrativ metodik har använts vid såväl insamling och sammanställning som vid analys av texter. Ett sådant angreppssätt har som huvudsakligt mål att skapa en ökad förståelse för ett särskilt problemområde och tar ofta sin utgångspunkt i praktikers intressen eller aktuella behov (Bryman, 2018). Vid analysen kommer vi därför att iscensätta våra tolkningar i förhållande till den betydelse instrumenten kan ha för praktiskt relevanta frågeställningar och utmaningar. Genomgången av litteraturen har dock strävat efter en procedur som är grundlig och noggrann för att uppfylla vetenskapliga krav på tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet.

Den litteratur som ligger till grund för sammanställningen är huvudsakligen publicerad det senaste decenniet. I ett första steg genomfördes litteratur-

sökningar utifrån relevanta sökord, t.ex. *child's/childrens plan*; *samordnad individuell plan*; *SIP*. Eftersom forskningen kring dessa planer ännu så länge är ganska begränsad tillfördes även olika typer av utvärderingar och uppföljningar gjorda av forskare. Ursprungliga sökningar kompletterades också med manuella genomgångar av de valda texternas referenslistor. Sammantaget ligger 35 texter (vetenskapliga artiklar, avhandlingar, utvärderingar eller rapporter) till grund för analysen.

Resultat

Planernas utformning och innehåll

Till att börja med kan noteras att namnet "barnets plan" indikerar ett ägandeförhållande, vilket kan uppfattas som en markering av att den i första hand just ska vara barnets och att den finns för barns och ungas skull. Den svenska benämningen "samordnad individuell plan" har däremot ett påtagligare byråkratiskt tilltal med fokus på de (samordnings)processer som ska ske för planens upprättande.

I den skotska lagstiftningen förordas att alla verksamheter som rör barn och unga ska införa en enda planeringsprocess för att åstadkomma ett integrerat och effektivt tillhandahållande av insatser för att på bästa sätt skydda, stödja och främja deras utveckling (Scottish Government, 2013; 2016). SIP saknar däremot en specifik lagstiftningskoppling, utan refererar istället till befintlig lagstiftning för socialtjänst respektive sjukvård. Dock anges inte förskolan eller skolan då de inte är ansvariga för att upprätta en SIP (men är tvungna att medverka när

så begärs av övriga parter) (SKL, 2019). BP är alltså tätare bunden till den generella ("hårda", lagstiftningsmässiga) policyn än SIP och inkluderar också tydligare idén om att barns och ungas vardagssammanhang bör vara utgångspunkten för insatserna. SIP är mer av tillskott till befintlig policy som avser att harmoniera med värden inom delvis olika områden, och är mer beroende av "mjuk" policystyrning för implementeringen.

Både BP och SIP är tydligt kopplade till Barnkonventionen. Syftesformuleringarna är också likartade: att skapa bättre förståelse för barnets behov, samordna insatser i ett tidigare skede, tydliggöra ansvar och följa barnets framsteg. Den tänkta målgruppen är delvis samma och det talas t.ex. i båda fallen om "alla barn och ungdomar" (som är i behov av mer stöd). SIP omfattar även vuxna individer.

I Skottland är det den namngivna stödpersonen (ofta utsedd inom skolan) som vanligtvis initierar en BP och som även fortsättningsvis utgör en viktig samverkanspart. Ansvaret för en SIP åvilar däremot inte en särskild funktion/yrkesutövare utan en organisation, sjukvården eller socialtjänsten. En konsekvens är att den svenska modellen förutsätter att organisationerna utvecklar passande former och funktioner för denna uppgift, samt förfogar över lämplig kompetens. Trots detta ansvarsförhållande har det visat sig att de flesta SIP initieras av förskola eller skola (SKL, 2019, s. 25).

I Skottlands modell betonas: "*one child, one meeting, one plan*" (Robert-

son, 2014, s. 173), d.v.s. intentionen är ett enda inledande planeringsmöte, som sedan kan följas av flera uppföljningsmöten. Utvärderingar av modellen visar dock att det i synnerhet i mer komplicerade fall krävdes flera möten (Stradling et al, 2009). I de svenska texterna är motsvarande skrivningar inte lika tydliga och det talas ofta om SIP-möten i pluralis (SKL, 2019). Även detta går att förstå som ett uttryck för instrumentens olika ursprung: en del av ett sammanhållet reformarbete i Skottland, alternativt ett sätt att sammanlänka befintliga system i Sverige. Det kan därför ha varit svårt i Sverige att adressera delar av befintlig praxis i policystyrningen, utöver den som berör själva handhavandet av instrumentet.

När det gäller hur en plan ska skrivas så föreligger det också skillnader. En BP utformas i proportion till barnets behov och samtliga verksamheter förväntas bidra med relevant information på ett likartat och standardiserat sätt (vilket även syftar till att underlätta informationsdelning). Samtidigt ska den utformas språkligt så att den är lätt att förstå av såväl barn och unga som vårdnadshavare. Den ska skrivas i jag-form både när det gäller behov och önskvärd förändring. Även om sådana målsättningar även kan återfinnas i de policyområden som SIP anknyter till, saknas en samlad skrivning specifikt riktad till planen, vilket ger praktikerna större handlingsutrymme.

Även i direktiven om vad planen ska innehålla skiljer det sig åt. En BP ska struktureras av risker och skyddande faktorer utifrån välbefinnandehjulets

åtta indikatorer och ta barns hela livssituation i beaktan (Scottish Government, 2012). En BP kan integrera bedömningar/utredningar från olika professionella eller specialister:

“It is not intended or designed to replace existing methodologies but it does contain the key elements of a single planning process that should in turn lead to a single child’s plan. As such, it can be used as a ‘common tool’ alongside and in conjunction with other processes and assessment tools” (ibid, s. 13).

SIP har ett tydligare fokus på att samordna insatser och ange mål för dessa – utan en gemensam analys av barnets behov (SKL, 2019). Man får således förlita sig på att de bedömningar av barnets situation som görs inom respektive organisation är allsidiga och väl utförda.

Liknande skillnader finns avseende uppföljningar där välbefinnandehjulet ska ligga till grund för bedömningen av barnets situation och fortsatta behov i Skottland, medan det i Sverige mer handlar om att följa upp om insatserna getts och resultatet av dessa.

I båda planerna framgår det att barns delaktighet är viktig och ska innehålla deras och vårdnadshavares synpunkter. Det finns dock en särskild sektion i BP där barnets synpunkter ska dokumenteras (Stradling et al, 2009). Skrivingar i SIP kring delaktighet är generellt svagare och planen ska ”när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde” (SKL 2019, s. 14).

I BP lyfts också betydelsen av samtycke och informationsdelning tydligt fram: *“The purpose of sharing information is to improve matters for a child or young person”* (Scottish Executive, 2007, s. 8), medan motsvarande texter i SIP är mer omfattande och har en mer juridisk och administrativ prägel, relaterad till hur svårigheter med sekretessreglerna ska hanteras (SKL, 2019).

Sammantaget kan man betrakta planerna som uttryck för samverkan och se dem som *gränsobjekt* (Bowker & Star, 2000) vars konstruktion vittnar om dess bakomliggande logik. Där BP innebär en högre grad av interprofessionellt samarbete med olika kunskapskällor som ska integreras i varandra och smälta ned i en gemensam bild, innebär SIP-arbetet en koordinering där olika, mer eller mindre, färdiga bilder ska jämkas samman till en gemensam överenskommelse och vad respektive part förmodas göra.

Planernas införande

De utvärderingar och studier av planerna som genomförts visar att såväl kontextuella, organisatoriska som professionella villkor varit viktiga begränsande eller främjande faktorer vid deras införande. Under GIRFEC-modellens implementering fanns farhågor för ökad byråkrati hos främst elevhållsovården, barnpsykiatrien och barnsjukvården (Stradling et al, 2009; Peterson, 2015). Vid utvärderingen av pilotprojektet i Highland-regionen (där implementeringen varit mest framgångsrik) visade det sig dock att idén om en enda plan över tid fått stor acceptans hos merparten professionella

(Robertson, 2014; Stradling et al, 2009). Personal i skolan välkomnade överlag också övergången till en mer enhetlig dokumentation användbar i alla verksamheter (Education Scotland, 2012):

“A Single Child’s Plan was becoming the norm rather than different plans being developed by different services, often functioning in parallel” (Statham, 2011, s. 29).

I Sverige framkommer en dubbelhet: å ena sidan en generell positiv inställning till samverkan och till SIP bland professionella (Nordström, 2016; Winqvist, 2016), å andra sidan stora svårigheter att få till systemet i praktiken där tidigare besvikelser av samverkan och revirstrider har kunnat påverka arbetet med SIP negativt (Nordström et al, 2016). SIP har t.ex. beskrivits som *”ett konflikthanteringsinstrument som används för att tvinga samverkanspartner till samverkan och att få parterna att tillsätta önskad åtgärd”* (ibid, s. 46). Ibland avstår också viktiga aktörer från att komma till SIP-möten (Winqvist, 2016). Det tycks särskilt gälla personal från barn- och ungdomspsykiatri som hellre prioriterar den egna patientkän än att *”tvingas närvara på ett SIP-möte”* kring barn som inte är aktuella i den egna organisationen (Nordström et al, 2016, s. 45). Andra hinder som nämns rör mer generella samverkansutmaningar såsom bristfälliga resurser, brist på tid och betydande personalomsättning (Socialutskottet, 2017).

Att skolans roll i SIP-arbetet inte anges i lagtexter har medfört en otydlighet och att de inte ses som en jäm-

bördig part gentemot socialtjänsten eller hälso- och sjukvården (ibid). Skolpersonal som intervjuats har också uttryckt frustration över trögheten i att åstadkomma samverkan med barnpsykiatri och socialtjänsten (Nordström et al, 2016), och att de saknar möjlighet att själva kalla till SIP-möte i samma utsträckning som de andra parterna.

Samordnade planers betydelse för berörda parter

De båda planerna har fått olika betydelse för de som huvudsakligen är berörda av dem, d.v.s. professionella, barn och deras föräldrar. I utvärderingen av pilotsatsningen med att implementera GIRFEC i Highland-regionen framkom det att BP bidragit till att antalet planeringsmöten minskat. Man säger att tidigare kunde familjer bli kallade till fyra, fem möten där de tillfrågades samma frågor från olika verksamheter, men att¹:

“That situation has changed and the children’s services and agencies in the pathfinder area have clearly bought into the idea of a single Child’s Plan meeting. This support for the single Child’s Plan and the single multi-agency planning meeting is now becoming widespread across Highland” (Stradling et al, 2009, s. 133).

1 Även om tanken med ett enda möte inte fungerade fullt ut i Skottland generellt, blev vissa familjer alltså kallade till ett flertal möten (Scottish Government, 2009)

Samma utvärdering visade också att planeringsmötena hade blivit mer lösningsinriktade. I en studie av samverkansmöten utifrån GIRFEC i en skolkontext visade det sig att lärares kunskap och självtillit kring vilka insatser och aktiviteter som bäst kan tillgodose barnens behov stärktes via gemensamma möten med andra professionella (Octarra, 2017).

Av en analys av 97 barnplaner under pilotprojektet framgick det dock att formulerade målsättningar ibland var otydligt kopplade till välbefinnandehjulet, eller i alltför låg grad återspeglade barnets önskemål. Många av de granskade planerna hänvisade också till genomförda insatser, snarare än till barnens uppnådda förändring (Stradling et al, 2009). En studie visade att tvärprofessionella bedömningar och gemensamma planer bidrog till att fler relevanta insatser gavs (Robertson, 2014). Den administration som var kopplad till planeringsprocessen kunde samtidigt uppfattas utmanande (Astbury, 2014). Coles et al, (2016) menar att den helhetliga och integrerade modellen inneburit fördelar för både organisationer och barn:

“This reflects a shift from the traditional, often entrenched “silo” mentality – single-service models where agencies, operating independently of one another, are concerned only with the sole aspect of the child’s life that is their responsibility – to viewing needs and concerns within the broader context of the whole of a child’s life and taking a collaborative, multiagency approach to meet

those needs at an early stage” (ibid, s. 346-347).

Av en utvärdering av barnplaner framgick det att merparten barn och föräldrar var positiva till det nya arbetssättet och kände sig mer involverade i de beslut som rörde dem (Anderson, 2014). Samtliga föräldrar hade kunskap om planens innehåll, men samtidigt ansåg en majoritet av dem att informationen i den var alltför omfattande och ofta upprepande. Många uttryckte också att de kände sig nedtryckta av innehållet i planen. Merparten av barnen var dock positiva till att de tillfrågades av de professionella om sina åsikter eller tankar och upplevde sig lyssnade på:

“I went to the meetings to talk about my Plan. Everyone listened to me and asked me how I felt about things and what I wanted to happen. It’s good that people ask you how you feel, I told them I wanted to stay with Granny and Grandpa” (Eli, åtta år, i Anderson, 2014, s. 26).

De flesta av barnen hade inte sett sin plan och var osäkra på om deras synpunkter hade tagits med i den. När det gällde planerade insatser och resultat uppfylldes i en tredjedel av fallen dock inte föräldrarnas förväntningar. Dessa avsåg huvudsakligen åtgärder relaterade till skolan. I nästan hälften av fallen uppfylldes målsättningen till fullo, medan en lika stor andel planer endast adresserade en del av de uppsatta målen. Nästan alla barn och en stor majoritet av föräldrarna tyckte

emellertid att den hjälp barnen fått via planen hade bidragit till förbättringar för dem. En fjärdedel av de undersökta planerna hade dock inte följts upp.

I svenska studier och utvärderingar ges en något annorlunda bild av SIPs betydelse för berörda. Det framkommer visserligen exempel på samverkansmöten präglade av respekt för varandras kompetens där tillfälle gavs till att förmedla kunskap om de andra parternas uppdrag och arbetssätt (Nordström, 2016; Nordström et al, 2016), samt att SIP gav en tydligare helhetsbild och bättre behovsbedömning (Winqvist, 2016). Övergripande drar dock Socialutskottet (2017) slutsatsen att det verkar vara *”svårt att bryta upp stuprörsbeteende oavsett hur man lagstiftar”* (s. 27). I en omfattande studie med professionella framgick att planens fokus hade förskjutits *”från brukarens behov till en förväntan på vad en annan verksamhet skall utföra”* (Nordström et al., 2016, s. 55). Liknande resultat ses i en rapport kring samverkan med funktionshindrade barn:

”Nu har vi mötts runt samma barn åtta gånger, vi konstaterar samma behov, men ingen ser det som sitt ansvar att utföra det” (Socialstyrelsen, 2017, s. 31).

Barn och föräldrar beskrivs som tvungna att anpassa sig till befintliga organisationsstrukturer istället för tvärtom och att de professionella utgår från deras behov (Hedberg et al., 2018). Det framkommer också skrivningar om att barn och ungas problem förminskas eller förnekas under diskussionerna.

“Everything was so jumbled. No one cooperated with anyone else. They just threw crap at each other and blamed each other... I felt I couldn't stand to listen to it” (tonåring, ibid, s. 7).

Socialutskottet (2017) konstaterar att berörda barn och unga sällan deltar på SIP-möten. En orsak som nämns är tidsbrist hos de professionella. Hedberg et al. (2018) menar att en annan anledning är att samarbetsproblem mellan verksamheterna öppet kunde visas upp inför familjerna på SIP-möten och att de ansågs kunna ta skada av att medverka. Det var även vanligt att de åtgärder som planerats och överenskommits i en SIP (i likhet med BP) inte alltid genomförs (Winqvist, 2016; Socialstyrelsen, 2017).

Diskussion

Jämförelsen mellan de båda planeringsinstrumenten BP och SIP visar stora likheter i intentionerna om att skapa en helhetlig förståelse kring barn och unga i utsatta situationer, att involvera deras egna röster i arbetet och komma fram till insatser som de involverade står gemensamt bakom och utfäster sig att genomföra.

Litteraturgenomgången indikerar samtidigt stora skillnader i hur modellerna införts och realiserats, där BP i Skottland förefaller ha fungerat bättre i jämförelse med motsvarande försök med SIP i Sverige. Barnet som ägare och subjekt i sin plan verkar exempelvis kommit betydligt längre i Skottland. En förklaring skulle kunna härledas till att BP ingår i ett större koncept som har fått starkt politiskt

stöd där ett flertal nationella reformer syftat till en genomgripande förändring av arbetet med barn och unga generellt. SIP däremot kan ses som ett sätt att koppla samman befintliga system i ett gemensamt arbete och har backats upp med mindre tillägg till strukturer och lagstiftning. Trots planernas idégemenskap kommer alltså socialpolitisk och kulturell kontext att ha stor betydelse för utfallet. SIP avser att etablera tillfälliga korsningar mellan olika spårbundna arbetssätt och organisationslogiker, vilket verkar erbjuda en mindre stabil grund för samverkan än om det etableras som mötesplats inom ramen för ett holistiskt policyramverk som BP kan ses som.

En hel del av utmaningarna rörande samordnade processer relaterar till inbyggda och svårlösta motsättningar och gränsdragningar hos professionella mellan det egna kärnuppdraget och att prioritera sådant som ligger utanför och i svårstyrbara konstellationer (Lamont & Molnár, 2002; Liljegren, 2008). De förväntas prioritera sin moderorganisations uppdrag och vidmakthålla gränser gentemot andra verksamheter, samtidigt som de vid samverkan ska arbeta utifrån en gemensam målsättning och överskrida dessa gränser (Thomson & Perry, 2006). Ju tydligare verksamheternas huvudsakliga uppdrag är, desto större risk är det för individer med komplexa behov att hamna emellan eller utanför (Grape, 2015). Edwards (2011) menar att det gränsarbete som måste till för att överskrida institutionella hinder handlar om att erkänna det mellanliggande uppbyggandet av relationella (kunskaps)ob-

jekt, genom vilket ett gemensamt fokus skapas på frågor som förmår tydliggöra var och ens position och kunskaper och sammanföra dessa till något helhetligt.

En av litteraturgenomgångens viktigaste slutsatser är att många av de hinder som identifierats relaterar till generella och strukturella svårigheter i samverkansarbetet runt barn som riskerar att fara illa (Danermark & Kullberg, 1999). Det är därför viktigt att ställa rimliga förväntningar på vad ett planeringsinstrument kan tillföra. De professionella i praktiken kan i praktiken sakna både möjligheter eller resurser för att leva upp till såväl upprättandet som till genomförandet av de planer som utvecklast tillsammans med barn och föräldrar, då de strukturella förändringar som skulle krävas ligger bortom planernas räckvidd (Davis & Smith, 2017).

Ett antal mer generella utmaningar för utvecklingsarbete kring stöd till barn och unga framkommer också från jämförelsen mellan de olika modellerna.

- Övergripande kan olika samordningsprocesser kring barn och unga ses som faktiska sätt att realisera barnkonventionen. Det handlar om att samtliga barn, även de som ofta undantas (t.ex. yngre barn, barn och unga med funktionsnedsättningar) ska ges en huvudroll i sin planeringsprocess. Att nå dithän kräver att traditionella, spårbundna vägar inom organisationer och professioner utmanas och där motsättningar mellan intressen synliggörs, samt där

frågor om makt och kontroll över förändrings- och arbetsprocesser adresseras.

- Ett helhetstänkande kring barn och unga utmanar också den långt gånga specialiseringen inom välfärdsorganisationerna genom att sätta barns livsvärld i centrum. Barnet lever i vardagssammanhang där förskola/skola (vid sidan av familj och fritidssammanhang) är centrala. Hur skolor ska bli plattformar för insatser och planeringsprocesser som fungerar inkluderande för barn och unga, är därför en central fråga. Här kan resurstillskott krävas, men det krävs också att motverka exkluderande mekanismer som förstärker känslan av att inte höra till eller misslyckas.
- Såväl BP som SIP, skillnaderna till trots, bygger på förhoppningen att genom rationella och strukturerade planeringsprocesser styra barns och ungas utveckling. Denna förhoppning kan bli till en självgenererande logik där det dokumenterade uttrycket och de processer som förknippas med detta skymmer att kärnan i mänsklig förändring till stor del bärs och utgörs av (tillitsfulla) relationer (Lerner et al, 2015). En översyn behövs därför göras kring det sammanhang av planer som en ny plan ska införas i. Om planer läggs till planer kan målet om en förenklad administration i praktiken tvärtom leda till ökad administration (något som setts både i BP och SIP) och det finns en uppenbar risk att planerna blir till ytterligare ett byråkratiskt verktyg i

en redan papperstygad vardag (jfr Agevall et al, 2017), vilket i sin tur riskerar att ta ytterligare tid från kontakten med barn och deras föräldrar (Grefve, 2017).

Litteratur

- Agevall, L., Jonnergård, K. & Krantz, J. (2017). *Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? – Om dokumentstyrning av professioner*. Växjö: Linneaus University Press.
- Anderberg, M., Forkby, T., & Thelin, A. (2020). A pendulum swing in child welfare policy – the case of implementing GIRFEC in Sweden. *Nordic Social Work Research*, doi:10.1080/2156857X.2020.1823874
- Aldgate, J. (2008). *Why Getting it right for every child makes sense in promoting the wellbeing of all children in Scotland*. Edinburgh: The Scottish Government.
- Anderson, T. (2014). *My Child's Plan: My views. A Highland Children's Forum consultation on behalf of the Highland Council*. Inverness: Highland Children's Forum.
- Astbury, R.A. (2014). *What processes will support effective shared decision making when health visitors and parent are planning to improve the wellbeing of babies and children within the context of the Getting It Right For Every Child (GIRFEC) Policy Framework?* Edinburgh: The University of Edinburgh.
- Axelsson, R. & Bihari Axelsson, S. (2013). *Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd*. Lund: Studentlitteratur.
- Blomqvist, C. (2012). *Samarbete med förhinder – om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj*. Göteborg: Göteborgs Universitet.
- Bowker, G. C., & Star, S. L. (2000). *Sorting things out: Classification and its consequences*: MIT press.
- Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Uppl. 3. Malmö: Liber.
- Coles, E., Cheyne, H., Rankin, J. & Daniel, B. (2016). Getting It Right for Every Child: A National Policy Framework to Promote Children's Well-being in Scotland, United Kingdom. *The Milbank Quarterly*, 94(2), 334-365.
- Colville, T., Montgomery, S. & Lentz, J. (2017). Spørg barnet – om inddragelse af børn i læringsmæssig praksis. Den tværprofessionelle udfordring og nye

- perspektiver på inklusionsarbejdet med børnene i centrum. *Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift*, 54(2), 59-74.
- Danermark, B. & Kullberg, K. (1999). *Samverkan. Velfärdsstatens nya arbetsform*. Lund: Studentlitteratur.
- Davis, J.M. & Smith, M. (2017). Children's rights, social justice and family support. I Dolan, P. & Frost, N. (red.). *The Routledge Handbook of Global Child Welfare*. London: Routledge.
- Education Scotland (2012). *Getting it right for every child: Where are we now? A report on the readiness of the education system to fully implement Getting it right for every child*. Livingston: Education Scotland.
- Edwards, A. (2011). Building common knowledge at the boundaries between professional practices: Relational agency and relational expertise in systems of distributed expertise. *International Journal of Educational Research*, 50(1), 33-39.
- Grape, O. (2015). Samverkan inom och mellan människobehandlande organisationer. I Johansson, S., Dellgran, S. & Höjer (red.) *Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete*. Stockholm: Natur och kultur.
- Grefve, C. (2017). *Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Slutrapport från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården*. Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet.
- Hansson, J. (2018). Tillit och professionell samverkan i elevhälsan – en fallstudie av Falu kommun. I Bringselius, L. (red.). *Styra och leda med tillit. Forskning och praktik. Forskningsantologi från Tillitsdelegationen*. Statens offentliga utredningar, SOU 2018:38. Stockholm: Nordstedts Juridik.
- Hedberg, B., Nordström, E., Kjellström, S., & Josephson, I. (2018). "We found a solution, sort of" – A qualitative interview study with children and parents on their experiences of the coordinated individual plan (CIP) in Sweden. *Cogent Medicine*, 5(1), 1-14.
- Huxham, C. (2003). The challenge of collaborative governance. *Public Management*, 2(3), 337-357.
- IVO (2019). *Barn och unga som riskerar att drabbas av bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja. Kortversion av förstudierapporten*. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
- Kalkan, A., Sandberg, J. & Garpenby, P. (2014). Management by Knowledge in Practice – Implementation of National Healthcare Guidelines in Sweden. *Social Policy Administration*, 49(7), 911-927.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives and public policies* (Updated 2nd ed.. ed.). Boston: Longman.
- Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual review of sociology*, 28(1), 167-195.
- Lerner, R.M., Lerner, J.V., Bowers, E.P., & Geldhof, J.G. (2015). Positive youth development and relational-developmental-systems. In Overton, W.F., Molenaar, P.C.M. & Lerner, R.M. (Eds.). *Handbook of child psychology and developmental science: Theory and method*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 1-45.
- Liljegren, A. (2008). *Professionellt gränsarbete: socionomexemplet*. Göteborg: Göteborgs universitet, socialt arbete.
- Nordström, E. (2016). *Samordnad individuell plan (SIP). Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter*. Licentiatavhandling. Jönköping: Jönköping University.
- Nordström, E., Josephson, I., Hedberg, B. & Kjellström, S. (2016). Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan. *Socialvetenskaplig tidskrift*, 23(1), 37-57.
- Ocarrar, H.S. (2017). *Making Visible Inter-agency Working Processes in Children's Services*. Edinburgh: The University of Edinburgh.
- Peterson, A. (2016). *Personalizing Education at Scale: Learning from International System Strategies*. Cambridge, Massachusetts: Harvard Graduate School of Education.
- Robertson, A. (2014). Child Welfare Assessment Practices in Scotland: An Ecological Process Grounded in Relationship-Building. *Journal of Public Child Welfare*, 8(2), 164-189.
- Scottish Executive (2007). *Guidance on the Child's or Young Person's Plan*. Edinburgh: The Scottish Executive.
- Scottish Government. (2009). *Changing Professional Practice and Culture to Get it Right for Every Child. An Evaluation of the Development and Early Implementation*

- Phases of Getting it right for every child in Highland: 2006-2009*. Edinburgh: The Scottish government.
- Scottish Government (2012). *A guide to Getting it right for every child*. Edinburgh: The Scottish Government.
- Scottish Government (2013). *UNCRC: The foundation of Getting it right for every child*. Edinburgh: The Scottish Government.
- Scottish Government (2016). *Child's Plan. Providing a consistent approach to planning for children who need coordinated support*. Edinburgh: The Scottish Government.
- Scottish Government (2017). *Supporting Supporting Children's Learning: Statutory Guidance on the Education (Additional Support for Learning) Scotland Act 2004 (as amended)*. Edinburgh: The Scottish Government.
- SKL (2018). *Handlingsplan mot missbruk och beroende. Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år*. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
- SKL (2019). *Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år (version 6.0)*. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
- Skolverket & Socialstyrelsen (2018). *Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga*. Delredovisning 2018. Stockholm: Skolverket.
- Socialstyrelsen (2007). *Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa*. Stockholm: Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen.
- Socialstyrelsen (2017). *Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd om samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd*. Stockholm: Socialstyrelsen.
- Socialutskottet (2017). *Samordnad individuell plan (SIP) – en utvärdering*. Stockholm: Riksdagstryckeriet.
- SOU (2016). *Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera*. Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk skolfrånvaro. SOU 2016:94. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
- Statham, J. (2011). *A review of international evidence on interagency working, to inform the development of Children's Services Committees in Ireland*. Dublin: Department of Children and Youth Affairs.
- Stradling, B., MacNeil, M. & Berry, H. (2009). *Changing Professional Practice and Culture to Get it Right for Every Child. An Evaluation of the Development and Early Implementation Phases of Getting it right for every child in Highland: 2006-2009*. Edinburgh: The Scottish Government.
- Thomson, A.M. & Perry, J.L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(1), 20-32.
- Widmark, C. (2015). *Divergent conceptions. Obstacles to collaboration in addressing the needs of children and adolescents*. Stockholm: Karolinska Institutet.
- Winqvist, M. (2016). *Uppföljning av arbetet med Samordnad Individuell Plan i Uppsala län*. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län.